



République Algérienne Démocratique Et Populaire
Ministère De L'enseignement Supérieur Et De La Recherche Scientifique
Université Constantine 3
Faculté De Médecine
Département De Médecine



Cours de sémiologie :

La sémiologie vasculaire pathologique

Dr ZINEB BOUACHIBA
Maitre-assistant en Médecine Interne- EHDM

Enseignement de 3ème année médecine.
Année universitaire 2025-2026.

I. Définition de la séméiologie vasculaire :

. La séméiologie vasculaire est l'étude de l'ensemble des signes cliniques (symptômes et signes physiques) en relation avec une pathologie, qu'elle soit acquise ou congénitale, affectant le système vasculaire :

Artériel

Veineux

Lymphatique

II. L'Interrogatoire du Patient Vasculaire

L'interrogatoire est l'étape fondamentale de l'examen clinique vasculaire. Il permet de formuler l'hypothèse diagnostique principale.

A. Principes de l'Interrogatoire ;

Caractéristique	Objectif
Relationnelle	Écoute, empathie, communication adaptée pour instaurer la confiance et garantir l'exhaustivité des informations.
Méthodique	Structuré, avec des questions neutres et ouvertes , pour cibler les éléments pertinents pour le diagnostic.
Souple	Le déroulement est adaptatif et non linéaire pour clarifier les informations au fur et à mesure.

B. Contenu de l'Interrogatoire

- Motif de Consultation/Hospitalisation
- **Histoire de la Maladie** Actuelle
- **Chronologie** des troubles perçus par le patient.
- **Antécédents Familiaux** : Cruciaux car de nombreuses pathologies vasculaires ont une composante héréditaire (varices primitives, maladie thromboembolique, thrombophilies).
- **Mode de Vie** : station debout prolongée, outils vibrants ,sports intensifs, longs trajets.
- **Facteurs de Risque** : essentiels pour l'athérosclérose, l'insuffisance veineuse et les thromboses.

--Évaluation des facteurs constitutionnels (âge, sexe, hérédité)

-- acquis/modifiables (tabagisme, troubles métaboliques, sédentarité, traitements hormonaux)

- **Analyse des Symptômes Vasculaires :**

- Description détaillée (type, localisation, intensité, évolution).

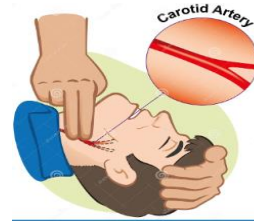
- Circonstances d'apparition : distance de marche pour la claudication intermittente.

- Nature des douleurs : Souffrance tissulaire en aval (artériopathies ischémiques) ou en amont (maladies veineuses), inflammation (phlébites), thrombose ou dissection.

- Signes associés : Évaluation objective des acrosyndromes (modifications de couleur), troubles trophiques ou dysfonctionnements d'organes (dyspnée, troubles érectiles).

- **Traitements en Cours :** identifier facteurs iatrogènes ou détecter des antécédents pathologiques non signalés.

- **examen clinique complet:** cardiaque, respiratoire, neurologique, digestif, urinaire et génital.



II. Examen Physique du Patient Vasculaire :

Sa réalisation peut nécessiter divers outils comme un tensiomètre, un stéthoscope, un Doppler de poche, un mètre ruban, un garrot, un marteau réflexe et un monofilament.

A. Sémiologie Artérielle

1. Inspection :

-L'inspection se fait d'abord debout (morphologie, démarche) puis en position allongée sur le divan.

-**Données Morphométriques :** Taille, poids, IMC, tour de taille.

-**Observation Générale :** Attitude antalgique, asymétrie des membres.

-**Téguments (Peau) et Phanères :**

- Couleur : Rechercher pâleur (ischémie), cyanose (stase, hypoxie) ou érythrose (rougeur).

- Troubles Trophiques : Peau sèche, perte de pilosité, fissures, ulcères (souvent signes d'une artériopathie grave).

- Trajets Artériels : Identification d'anomalies comme des anévrysmes (dilatations pulsatiles).

-**Signes spécifiques d'insuffisance valvulaire aortique :**

- Signe de Musset :** Secousses rythmiques de la tête synchrones du pouls.

- Signe de la sonnette (visible sur l'artère humérale) :** Mouvement de reptation sinueux et très battant à chaque systole.

2. Palpation

-**Prise des pouls :** Systématique et comparative aux quatre membres (fémoral, poplité, tibial postérieur, pédieux).

-**Évaluation de la fréquence, du rythme et de l'intensité.**

-**Température cutanée :** Recherche d'un gradient de chaleur ou d'une froideur.

-**Signes de l'ischémie aiguë :** (Les 6 P : Pâleur, Paresthésie, Parésie, Pouls abolis, Douleur (Pain), Poikilothermie/Froid).

2.2. PALPATION DES TRAJETS ARTÉRIELS :

L'examen des pouls périphériques : est essentiel en clinique. Il se fait en décubitus dorsal en palpant les trajets artériels des membres supérieurs et inférieurs, ainsi que d'autres artères comme la carotide et la temporale. Toute asymétrie ou absence de pouls peut révéler une pathologie

artérielle.

Les anomalies du pouls artériel :

- Les troubles du rythme cardiaque.
- Les modifications de l'amplitude des battements artériels.
- La perception de frémissement ou thrill.

a- Les troubles du rythme cardiaque : il s'agit soit de

- Irrégularité -arythmie
- Bradycardie
- Tachycardie

b- Les modifications de l'amplitude des battements artériels :

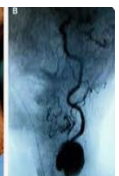
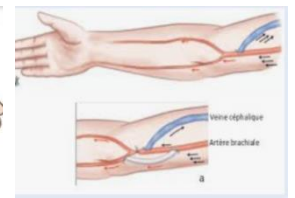
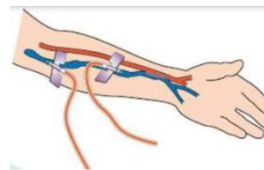
- L'affaiblissement général des pouls :
 - Microsphygmie (diminution du débit cardiaque)
 - Rétrécissement aortique (RA)
 - Insuffisance cardiaque gauche (ICG)
- L'affaiblissement ou disparition élective d'un pouls artériel :
 - Artérite (inflammation d'une artère)
 - Thrombose ou embolie
- L'affaiblissement ou abolition des pouls fémoraux :
 - Coarctation de l'aorte
 - thrombose de la partie terminale de l'aorte
 - Thrombose des deux artères iliaques.
- L'augmentation généralisée d'amplitude des pouls artériels :
 - Éréthisme cardiaque
 - Hyperthyroïdie
 - insuffisance aortique (IA) : pouls de Corrigan
- L'amplitude du pouls peut varier avec les mouvements respiratoires : Pouls paradoxal de Kussmaul
 - Épanchement péricardique de grande abondance.
 - La péricardite constrictive.

c- La perception de frémissement ou thrill :

- Systolique : les anévrysmes artériels
- Systolo-diastolique : fistule artério-veineuse

d- La perception des masses pulsatiles :

- Une masse battante et expansive : **un anévrisme**,
- une masse avasculaire peut battre sans expansion.
- Une expansion globale de l'artère : **une méga-artère**



1- L'auscultation :

À l'état normal :

Les artères sont silencieuses à condition de ne pas les comprimer.

À l'état pathologique :

L'apparition d'un souffle systolique, souffle systolo-diastolique ou un souffle continu est pathologique.

- **Aux artères carotides :**

- Thrombose ou sténose de la carotide
- RA (irradiation du souffle de RA aux carotides)

- **Gros troncs artériels :** la sous-clavière dans le creux sus-claviculaire ,l'axillaire en sous-claviculaire :

- Rétrécissement artériel athéromateux : Souffle Systolique
- Anévrisme artériel : Souffle Systolique
- Anévrisme artério-veineux : Souffle continu

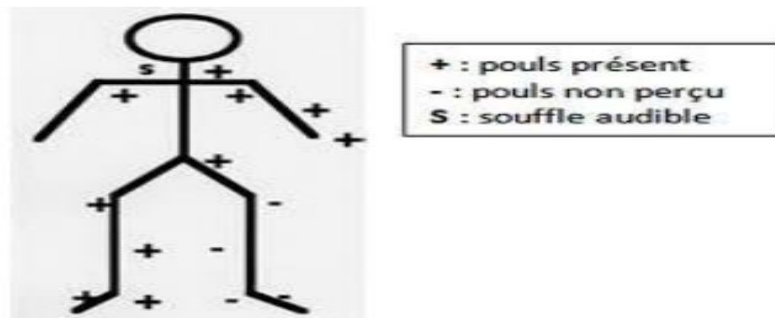
- **Artère rénale :**

- Sténose rénale : Souffle Systolique unilatéral, latéro-ombilical ou sus ombilical. Au niveau des flancs et en lombaire

- **Artère fémorale :**

- Insuffisance aortique (IA) : double souffle crural de Duroziez (S systolique et S diastolique).
- sténose fémorale.

Au terme de l'examen vasculaire, on put consigner nos données sur un schéma daté



4. Mesure de la pression artérielle :

1. Technique de mesure :

- Sphygmomanomètre = appelé couramment tensiomètre
- Le malade : position couchée ou assise
- Brassard : 1/3 inférieur de bras
- Effectuée aux deux bras
- Après 15 min de repos
- Elle peut se faire en position debout : la recherche d'hypotension orthostatique
- Profil tensionnel : **la règle des 3.**

3 mesures consécutives (à 1-2 minutes d'intervalle), **le matin** : avant le petit déjeuner (avant de prendre ses médicaments).

3 mesures consécutives (à 1-2 minutes d'intervalle), **le soir** : avant le coucher.

3 jours de suite au minimum, et si possible pendant 5 à 7 jours.



Résultats :

Normal : PAS $\leq$ 140 mm Hg

PAD $\leq$ 90 mm Hg

-Varie en fonction de l'âge.

- Différence de pression acceptable $\leq$ 20 mm Hg (pour la PAS)

Les anomalies de la pression artérielle :

a) L'hypertension artérielle :

PAS $>$ 140 mm Hg et, ou

PAD $>$ 90 mm Hg

b) L'hypotension artérielle :

- Collapsus cardiovasculaire

- insuffisance surrénale lente

-Hypotension des sujets jeunes et/ou sportifs

c) Les anomalies de la différentielle :

-Elargissement : IAO ex : 150/30 mm Hg (insuffisance aortique)

- Pincement :

IC ex : 90/70 mm Hg (insuffisance cardiaque)

5. Index de Pression Systolique :(IPS) l'intérêt dans la recherche d'une artériopathie des membres inférieurs.

- Un brassard pneumatique placé à la cheville est dégonflé, tandis que la pression systolique est mesurée avec une sonde Doppler au niveau de l'artère pédieuse ou tibiale postérieure.

- Cette pression systolique à la cheville est rapportée à la pression systolique humérale, pour obtenir l'index de pression systolique (IPS) que l'on considère anormal s'il est inférieur 0,9.

$$\text{IPS} = \text{PAS cheville} / \text{PAS bras} = 0,9 \text{ à } 1,3$$

6. Les syndromes d'ischémies des membres

6.1 L'ischémie aigue:

- une occlusion artérielle brutale par un embole sanguin venant du cœur gauche, il s'agit d'une **urgence** diagnostic et thérapeutique qui sera reconnue par les signes suivant :

-une **douleur violente** au niveau du membre ischémié.

-une **impotence fonctionnelle** totale avec troubles neurologique

-une **pâleur extrême** de marbre blanc associée à un **refroidissement** du membre perçu par le malade et palpé par le médecin

-une **abolition des pouls** en aval de l'oblitération

-en absence de traitement l'évolution se fait inévitablement vers la gangrène.

6.2. Ischémie chronique

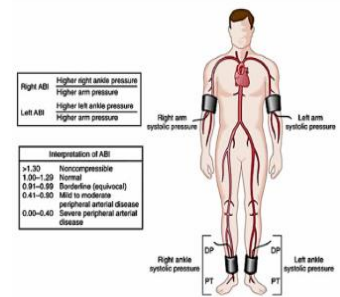
-une oblitération partielle et progressive d'une artère,

-artérite oblitérante des membres inférieurs

-elle évolue en 04 stades :

➤ **Stade I** : absence de signes fonctionnelle, mais diminution ou abolition d'un ou plusieurs pouls

➤ **Stade II** ou stade d'ischémie d'effort : caractérisé par la claudication intermittente : il s'agit d'une douleur à type de crampes sans



contracture musculaire qui apparaît à l'effort lors de la marche, surtout si elle est accélérée, qui disparaît lors du repos, et qui réapparaît pour le même effort. Cette douleur siège soit à la fesse, soit à la cuisse, soit au mollet,

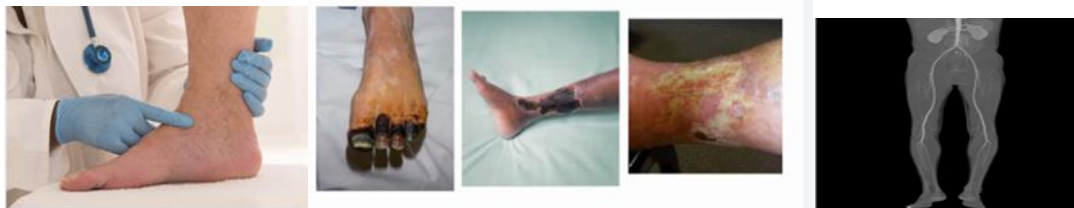
Elle s'aggrave dans le temps, apparaissant pour une distance de plus en plus faible : la diminution du **périmètre de marche**.

- **Stade III** ou stade d'ischémie de repos : caractérise par une douleur permanente existant même au repos, exagérée par le décubitus accompagne de trouble vasomoteur a type d'erythrocyanose
- **Stade IV** : c'est le stade de la gangrène qui est la nécrose du segment d membres ischemie, elle évolue en 02 phases :

-phase sèche aseptique : peu douloureuse

-phase humide : elle s'accompagne d'une infection et les douleurs deviennent plus intenses

A ce stade l'amputation du segment gangrené est indispensable d'où l'importance du diagnostic précoce d'une artérite avant l'apparition de la gangrène



B-Sémiologie veineuse :

L'examen de système veineux comprend : L'examen des veines jugulaires e L'examen des veines des membres inférieurs

1. L'examen des veines jugulaires :

-Les veines jugulaires externes sont plus facilement examinables.

On recherchera chez un patient installé en proclive dorsal à 45°.

1.1.une turgescence des veines jugulaires (TJ).

Le trajet des veines jugulaires externes passe en dehors du bord postéro-externe du muscle sternocléido-mastoïdien. Son aspect reflète les variations de pression de l'OD.

- Conditions d'examen :

Patient en décubitus dorsal en respiration normale, tête légèrement soulevée,

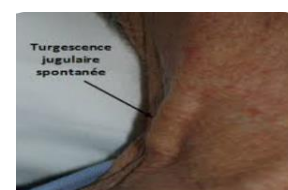
À l'état normal : poulx veineux plus visible que le poulx artériel mais non palpable

À l'état pathologique :

La distension permanente des jugulaires: (turgescence spontanée des jugulaires)

Il s'agit d'un signe d'insuffisance cardiaque droite :

- Insuffisance ventriculaire droite.
- Épanchement péricardique abondant.
- Péricardite constrictive.



1.2. Le reflux hépato-jugulaire (RHJ):

Technique :

Le patient est installé dans les mêmes conditions que pour la recherche d'une TJ. On se place à sa droite et on exerce avec le plat de la main droite une pression ferme sur le foie (dans l'hypochondre droit), tout en observant les veines jugulaires externes.

Résultat :

Le reflux hépato-jugulaire est positif s'il apparaît une turgescence jugulaire ou si une turgescence jugulaire préexistante se majore, ne disparaissant pas en inspiration profonde.



1.3. L'expansion systolique des jugulaires:

- Pouls systolique jugulaire de l'IT.
- Souvent associée à une expansion systolique du foie

1.4. La dissociation radio-Jugulaire :

Il s'agit d'un pouls jugulaire indépendant du pouls artériel :

- Le pouls veineux est soit plus rapide que le pouls artériel ; ce signe est retrouvé au cours de : bloc auriculo-ventriculaire du 3e degré, du flutter auriculaire.
- Soit plus lent que le pouls artériel au cours de : la tachycardie ventriculaire.

2. L'examen des veines des membres inférieurs :

À l'état normal :

Les veines des membres inférieurs ne sont pas visibles sauf au niveau de la malléole interne et du dos du pied.

À l'état pathologique : on recherche :

- Les varices des membres inférieurs
- la thrombose veineuse superficielle (TVS)
- La thrombose veineuse profonde (TVP)

a. Les varices des membres inférieurs :

Les varices correspondent à des dilatations tortueuses des veines du réseau de drainage superficiel des membres inférieurs.

- Position debout+++
- Disparaissent quand le membre est surélevé
- Peuvent se thromboser et entraîner ainsi une thrombose veineuse superficielle



b. La thrombose veineuse superficielle : TVS

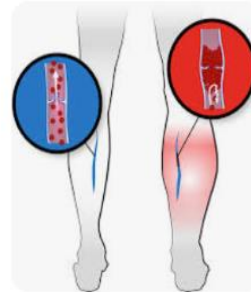
La TVS est une obstruction d'une veine superficielle par un thrombus, pouvant causer des complications si elle s'étend au système veineux profond.

- localisées aux membres inférieurs, aux membres supérieurs et au tronc.
- une douleur intense le long d'une veine, spontanée ou après un léger traumatisme, parfois aggravée par la marche
- Un placard inflammatoire très douloureux de forme oblongue. Il peut être circonscrit ou se poursuivre par un cordon veineux induré (1 à plusieurs dizaines de cm), sensible et violacé. Il n'y a pas d'adénopathie satellite associée. La limite supérieure du placard inflammatoire ou du cordon ne définit pas la limite supérieure du thrombus qui peut se situer beaucoup plus



c. La thrombose veineuse profonde (TVP) des membres inférieurs :

- Oblitération d'une veine profonde par un caillot sanguin.
- Sémiologie : Membre inférieur gonflé, rouge, chaud
- Douleur du mollet
- augmentation du volume : œdème
- augmentation de chaleur locale
- **Signe de Homans positif** : douleur provoquée du mollet à la dorsiflexion du pied.
- +/- signes de Pancarte (T°-FC)
- Complications :
 - Embolie pulmonaire.
 - Maladie post-phlébitique



d. syndrome cave inférieure :

Le syndrome de la veine cave inférieure (SCVI) est causé par une invasion ou une compression physique par un processus pathologique ou par une thrombose dans la veine elle-même.

Il se manifeste par :

- Circulation veineuse collatérale abdominale
- Hépatomégalie, douleurs abdominales.
- Ascite
- Œdème des membres inférieurs

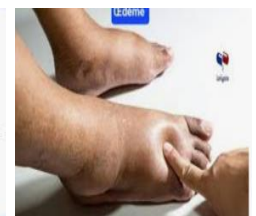


par une

e. syndrome cave supérieure :

Obstruction de la veine cave supérieure.

- Œdème en pèlerine



- Cyanose
- Circulation collatérale thoracique
- Turgescence jugulaire
- Autres: myosis, hypotrophie de l'éminence hypothénar
- Congestion
- Gêne respiratoire: toux, dyspnée, oppression thoracique
- Signes neurologiques
- Céphalées
- Vertiges.



III. Exploration de système vasculaire :

Système artériel :

Echographie-Doppler artérielle

- Artériographie
- Angioscanner
- Angio-IRM

Système veineux :

- Echographie-Doppler veineux
- Phlébographie

Dr Zineb Bouachiba
 Maître assistante EHDM
dr.bouachiba@gmail.com

